

5.6 Salud GESTIÓN

San Isidro tiene tres hospitales municipales, uno odontológico y una red de centros de atención primaria: una infraestructura que pocos municipios bonaerenses tienen. Y el turno se sigue sacando haciendo la cola.

Hoy: 78.217 millones, el 24,1% del presupuesto. Es, de lejos, la función más grande del Municipio. **Acá no proponemos fondos nuevos:** duplicar un sistema de este tamaño no entra en el margen fiscal, y el capítulo 3 lo demuestra.

Y hay que empezar reconociendo lo que se hizo, porque es mucho y este programa no lo discute. Entre 2025 y 2026 el Municipio renovó habitaciones y baños del Hospital Central, atacó las humedades, reacondicionó ascensores y cocinas en los tres hospitales, **y recuperó un montacamillas del Materno Infantil que llevaba años fuera de servicio.**

Porque el problema de fondo sigue ahí, y está documentado. En un recorrido por los hospitales municipales, médicos de planta y pacientes describieron **faltantes de reactivos, faltantes de medicamentos, falta de camas de internación y escasez de personal.** En el Hospital Central hay **tres pisos en desuso**, en mal estado, usados como depósito.

«El hospital podría dar para muchísimo más; parece más de lo que es», resumió uno de los médicos consultados. Eso se constató cinco meses después del cambio de gobierno, y los profesionales

El Municipio ya tiene turnos digitales andando. No los usó para los hospitales

El dato es este, y no necesita adjetivos. No hay turno médico en línea en ningún efector de salud humana del partido. Ni en los tres hospitales, ni en el odontológico, ni en los nueve centros de atención primaria. Son telefónicos o presenciales.

Y el turno para castrar una mascota se saca cien por ciento en línea, por la misma plataforma municipal con la que se pide una licencia de conducir, un aviso de obra o una copia de plano. El Municipio **ya tiene la infraestructura montada y operativa:** no la aplicó a los hospitales.

No es un problema de tecnología ni de dinero. Es de prioridad, y por eso entra en este capítulo como gestión y no como fondos nuevos.

LA SOLUCIÓN YA EXISTE, ES GRATIS, Y HAY QUE PEDIRLA

La Provincia de Buenos Aires tiene en funcionamiento **Mi Salud Digital:** turno por celular, historia clínica digital y teleconsulta por videollamada, con receta y orden integradas automáticamente. **La historia clínica digital ya opera en más de sesenta municipios bonaerenses** y el sistema lleva registrados más de 19,5 millones de turnos.

No hay que construirlo ni pagarlo: hay que adherir y conectar los efectores municipales. La Provincia entregó a hospitales y municipios más de 5.000 computadoras, lectoras de DNI e impresoras para eso. **Es la propuesta más barata de este programa y la que más rápido se nota:** el día que funcione, nadie pierde una mañana de trabajo para pedir un turno.

Teleconsulta para lo que no necesita ir al hospital. Renovar una receta crónica, una consulta por fiebre un domingo, un control de seguimiento. En las experiencias argentinas medidas la espera es de **3 a 6 minutos**, la atención dura entre 6 y 7, y el 86% de las consultas se resuelven. **Cada teleconsulta libera un turno presencial** para quien sí necesita el consultorio.

Arreglar los edificios, que el propio gobierno reconoce. La gestión actual identificó filtraciones y humedades como problema estructural de los hospitales municipales. Eso es obra, entra en la partida de obra, **y es exactamente lo que una comisión vecinal puede priorizar** con el mecanismo del capítulo 4.

La inteligencia artificial en salud no hay que proponerla: hay que auditarla

Este programa iba a proponer IA aplicada al diagnóstico por imágenes. Al buscarlo apareció que **ya está**, desde hace tres años, y eso cambia la pregunta entera.

Lo dice el propio Municipio. En abril de 2023 anunció ser «el primer municipio en sumar inteligencia artificial en salud», en los tres hospitales. Según la cobertura periodística de esos días hubo antes un año de prueba con estadísticas propias, y el software hace **triage:** marca si una imagen se aparta de lo esperado y **el médico decide**, que es exactamente la línea que este programa no cruza.

Y hay dos cosas que el anuncio dice y ninguna fuente respalda. El entonces secretario de Salud afirmó que el sistema reduce un 70% el error de diagnóstico y ahorra un 30% del tiempo en los casos urgentes. **No hay estudio, informe ni evaluación publicada detrás de esas dos cifras.** Son declaraciones, y este documento las trata como tales.

Ninguna fuente pública nombra al proveedor. Que un municipio contrate un sistema que interviene en un diagnóstico y no diga de quién es, es el hallazgo. **La ANMAT exige que el software cuyo uso previsto sea diagnóstico se registre como producto médico,** y de ese registro no hay rastro público.

LO QUE SÍ FALTA COMPRAR, Y NO ES SOFTWARE

La tomografía y la resonancia no son equipamiento propio de los hospitales municipales. Las tomografías funcionan sobre espacios concesionados a un tercero y la resonancia se contrata como servicio a un prestador privado, con licitaciones y prórrogas sucesivas.

Eso no es una irregularidad y este programa no lo presenta como tal. Es un dato de estructura que cambia cualquier discusión sobre diagnóstico por imágenes en San Isidro: **la decisión sobre el estudio que más pesa no está enteramente del lado del Municipio,** y conviene saberlo antes de prometer.

Y lo que decide si hay gasas: cómo se compra

Es la función más grande del presupuesto municipal —el 24,1%— y la que menos se puede mirar desde afuera. También es, en todo el mundo, donde se pierde más dinero público.

El dato general es contundente. Entre el **40% y el 60%** de los casos documentados de corrupción en sistemas de salud están vinculados a la compra y el suministro de medicamentos e insumos. No es una particularidad argentina: es dónde falla el mecanismo en cualquier país.

Y no hace falta que haya delito para que el daño exista. Cuando un hospital no puede saber cuánto paga otro hospital público por el mismo producto, es imposible detectar sobreprecios. **Basta con que falte la comparación para que el gasto se vuelva estructuralmente ineficiente,** sin que nadie robe nada.

Y en San Isidro ya pasó. En 2024 el Municipio denunció penalmente a exfuncionarios de Salud y directores de hospitales —**al menos diez personas**— por sobrefacturación en las viandas del Materno Infantil y el Ciudad de Boulogne, con un perjuicio estimado en **262 millones de pesos sólo en 2023.** Se rescindió el contrato y se dio de baja al proveedor del registro municipal.

CUATRO MEDIDAS, Y LA CUARTA ES LA QUE HACE QUE LAS OTRAS TRES SIRVAN

1 · Precio unitario público. Cada compra de insumos y medicamentos se publica con producto, cantidad, **precio unitario** y proveedor. No el total del expediente: el precio por unidad, que es lo único comparable. Es el mismo principio que el capítulo 1 aplica a los decretos de adjudicación.

2 · Stock a la vista, el mismo día. Qué insumo básico hay y cuál falta, por establecimiento. **Si en un hospital faltan gasas, eso tiene que poder verse desde afuera hoy,** no enterarse por un paciente. Y el dato ya existe: todo hospital lleva su stock.

3 · El control lo hace quien usa el hospital. La comisión vecinal de cada zona ve lo que se compró y lo que se ejecutó en los efectores de su territorio, con la obligación de respuesta fundada del capítulo 4. **El que espera el turno es el que mejor sabe si el insumo llegó.**

4 · Y la comparación la hace el sistema, no el vecino. El caso de los guantes se descubrió comparando un precio contra otro, dos años después. Publicar el precio unitario sirve sólo si alguien compara, y nadie tiene tiempo de comparar miles de compras. **El asistente del capítulo 4 compara solo:** contra las compras anteriores del mismo establecimiento, contra los otros dos hospitales y contra los municipios que publiquen, y avisa cuando algo se sale del rango.

Señala anomalías, no acusa. Dice «este precio está 40% por encima de la compra anterior» y muestra los dos documentos. Quién explica es el funcionario y quién decide si hay delito es un juez: **el sistema no imputa a nadie, acorta el tiempo entre que algo pasa y que se ve.**

Por qué esto no es «más transparencia». Publicar un precio unitario no es un gesto de apertura: es **el mecanismo que hace que el precio baje**, probado en hospitales públicos argentinos. La diferencia entre publicar el total de una licitación y publicar el precio por gasa es la diferencia entre no poder comparar y poder.

Compró equipamiento y abrió lo que faltaba. Tomógrafo de coherencia óptica, desfibriladores, respirador pediátrico, monitores para Neonatología, actualización del quirófano del Materno. Y una **primera sala de salud mental** en el Central, que además descongestiona la guardia.

Incluso empezó la digitalización. El Materno Infantil pasó de historias clínicas en papel a un sistema digital integrado, con 170 puestos de trabajo nuevos. **La pregunta de este programa no es por qué no se hace nada: es por qué no se termina.**

dijeron que en buena parte seguía igual. **No es de una gestión ni de la otra: es estructural.**

Y el turno se sigue sacando haciendo la cola. Una vecina de Boulogne lo describió así: llegar a la ventanilla después de una fila larga y que le digan que se acabaron, que vuelva la semana que viene. **«Uno falta al trabajo para venir.»**

Ahí está la distancia entre comprar un tomógrafo y que el sistema funcione. El equipamiento se inaugura y se fotografía. El turno, el insumo y la cama no.

El detalle, verificado en septiembre de 2026. En el Hospital Central, Cardiología, Diabetología, Endocrinología y Neurología se piden **sólo por teléfono.** En el Materno Infantil hay dieciocho especialidades por teléfono en una ventana de cuatro horas y veinte **sólo presenciales**, entre ellas Ecografía, electrocardiograma, Laboratorio y Radiología Infantil.

Hay además una página municipal llamada «Portal de turnos online» que no incluye salud: ofrece licencias de conducir, aviso de obra y copia de plano. **El nombre promete más de lo que da.**

Y recién entonces, publicar. Una vez que el turno es digital, el tiempo de espera por especialidad y por establecimiento existe como dato sin que nadie lo cargue a mano. Publicarlo deja de ser una promesa administrativa y pasa a ser la forma de saber dónde falta un médico. Lo mismo con la ejecución por centro y por zona, que hoy no se sabe: con 263.106 pesos por habitante al año en juego, esa es la diferencia entre saber y suponer si el sistema llega a Boulogne.

Qué no promete. No promete resolver la crisis salarial de los profesionales, que atraviesa a todo el sistema de salud argentino y excede a un municipio. Promete lo que un intendente decide: el sistema de turnos, la teleconsulta, el estado de los edificios y cómo se compran los insumos.

Por eso lo que se promete acá no es comprar: es publicar. Qué sistema es, quién lo provee, si está registrado ante la ANMAT, qué mide y con qué resultados. Y los datos del año de prueba, si existen: **serían la única evidencia argentina de resultados medidos en un municipio,** y hoy nadie los vio.

Y hay una razón de responsabilidad, no sólo de transparencia. El médico que usa la herramienta responde por su criterio; pero **el hospital y el Municipio responden como dueño y guardián de la cosa** cuando el daño viene de un defecto del sistema. Quien es responsable tiene que poder decir qué contrató.

Los egresados del programa desarrollan sobre los sistemas del Municipio y las universidades del partido validan, con el mismo esquema del capítulo 4. Y hay antecedentes públicos argentinos para mirar: RETINAR, del CONICET y la Universidad del Centro, es el mejor caso nacional, y el Hospital San Bernardo de Salta fue el primer hospital público argentino con IA en radiografía de tórax.

Y hubo un segundo hallazgo que casi no se comentó y que importa más acá: las dudas se repitieron en la compra de insumos hospitalarios —guantes descartables, entre otros— al detectar que varios materiales se compraban después a precios más bajos que los facturados en noviembre de 2023. **Se descubrió comparando un precio contra otro. Si ese dato hubiera sido público, se veía mientras pasaba y no dos años después.**

Hay un precedente argentino con resultado medido, y es sorprendente. La Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires empezó en 1996 a monitorear los precios de compra de sus hospitales y a difundirlos entre los propios establecimientos. **Sólo difundir la información redujo los precios un 13%** en el primer año.

No hizo falta un organismo nuevo, ni una ley, ni una auditoría. Alcanzó con que cada hospital pudiera ver lo que pagaba el de al lado. Eso es exactamente lo que San Isidro no tiene y podría tener el primer mes.

Y la guardia, en número. Ocupación en tiempo real: «catorce personas esperando, demora estimada cuarenta minutos», para que quien tiene que ir elija a cuál. **Como cifra y no como imagen:** no se transmite el interior de un hospital, porque hay pacientes e historias clínicas a la vista. Es más útil que un video y no expone a nadie.

Y este programa no acusa a nadie. No afirmamos que en San Isidro se compre mal ni caro: no lo sabemos, y no lo sabemos **porque el dato no se publica.** Eso es precisamente el problema. Un sistema que no se puede auditar desde afuera falla igual con funcionarios honestos.